

ANEXO 1: PROTOCOLO REVISADO

Teniendo en cuenta la reciente guía europea sobre el manejo de la endocarditis (Delgado V. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023 Oct 14;44(39):3948-4042), desde el PROA (**junto con los servicios de cardiología y cirugía cardíaca**) proponemos actualizar nuestros protocolos hospitalarios de prevención de endocarditis infecciosa (EI) frente a procedimientos invasivos a los que tengan que someterse pacientes de riesgo. Para ello se propone:

1) VALORACIÓN DEL RIESGO DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA:

Definición de paciente de **ALTO RIESGO DE EI** en los que se recomienda realización de profilaxis antibiótica:

- Portadores de prótesis valvular o material protésico utilizado para la reparación valvular así como válvulas implantadas a través de técnicas transcatóter. Pacientes con implantación de dispositivos de cierre de defectos de septo o apéndice de aurícula izquierda, injerto vascular, filtros de vena cava y sistema de derivación del sistema nervioso central ventrículo-atrial se consideran de riesgo dentro de esta categoría dentro de los primeros 6 meses tras la implantación.
- Endocarditis previa.
- Cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas (no se incluyen aquellos con alteraciones congénitas valvulares aisladas).
- Cardiopatías congénitas reparadas de forma completa con material protésico, conductos valvulares o shunts. El riesgo de EI para paciente con cardiopatías congénitas donde se realiza reparación transcatóter atrial o de septo intraventricular con dispositivos/cirugía con material protésico no valvular está también incrementado, pero los primeros 6 meses tras la cirugía.
- Paciente portadores de dispositivos de asistencia ventricular. (DAI)

- Trasplantados cardíacos

Definición de paciente de **RIESGO INTERMEDIO de EI**, en los que la profilaxis antibiótica no se recomienda de forma rutinaria pero **debe valorarse el caso del paciente de forma individualizada**:

- Valvulopatía reumática.
- Degeneración valvular no reumática.
- Valvulopatías congénitas incluida válvula aórtica bicúspide **y prolapso mitral**.
- Portadores de dispositivos cardiovasculares electrónicos (*marcapasos...*)
- Miocardiopatía hipertrófica.

2) PROCEDIMIENTOS INVASIVOS que se tienen que tener en cuenta en paciente de ALTO RIESGO DE EI para realizar profilaxis antibiótica:

- Procedimientos odontológicos de alto riesgo (recomendación IB), que incluyen: extracción dental, cirugía oral (incluida cirugía periodontal, cirugía de implantes, biopsias) y aquellos procesos dentales que impliquen manipulación gingival o de la región periapical del diente (incluida limpieza y endodoncia).

- Otros procedimientos no odontológicos (en este caso la recomendación se basa en opinión de expertos, IIb C): procedimientos **invasivos diagnósticos o terapéuticos** de tracto respiratorio (**broncoscopia, EBUS**), gastrointestinal(**colonoscopia, gastroscopia, CPRE, eco-endoscopia**), genitourinario (**cistoscopia, colocación catéter doble J, nefrostomias/recambio de nefrostomias**), cutáneo o musculo-esquelético.

PAUTAS DE PROCEDIMIENTOS DENTALES DE ALTO RIESGO (según guías ESC 2023). Una única dosis 30-60 minutos antes del procedimiento.

Situación	Agente	Adultos	Niños
No alergia a penicilina o ampicilina	Amoxicilina	2 gr oral	50 mg/Kg oral
	Ampicilina	2 gr im o iv	50 mg/Kg im o iv
	Cefazolina	1 gr im o iv	50 mg/Kg im o iv
Alergia a penicilina o ampicilina	Cefalexina ^{1 2}	2 gr oral	50 mg/Kg oral
	Azitromicina o Claritromicina	500 mg oral	15 mg/Kg oral
	Doxiciclina	100 mg oral	< 45 Kg: 2.2 mg/Kg oral > 45 Kg: 100 mg oral
	Cefazolina ²	1 gr im o iv	50 mg/Kg im o iv.

1. U otra cefalosporina oral de primera o segunda generación en dosis equivalentes

2. No usar cefalosporinas en caso de antecedente de anafilaxia, angiodema o reacción urticarial con el uso de penicilina o ampicilina.

PAUTAS PARA PROCEDIMIENTOS NO DENTALES: Ver en guía

